INFORME ESTRATÉGICO: EL ÁNGULO MUERTO DE LA NEURODIVERGENCIA

1. Justificación Teórica del Ángulo Muerto

El avance de la plataforma FAND depende de su capacidad para abordar realidades estructurales que las federaciones y redes asociativas tradicionales ignoran sistemáticamente. Los enfoques clásicos tienden a centrar sus esfuerzos en la infancia y en la adaptación conductual superficial para la tranquilidad del entorno. Este informe técnico identifica los cinco grandes vacíos globales desatendidos, denominados el 'Ángulo Muerto', estableciendo el marco conceptual necesario para fundamentar una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) blindada ante Bruselas.

2. Desglose Técnico de los 5 Grandes Vacíos

A. El Trauma del Masking Crónico (Camuflaje Social)

El esfuerzo inconsciente y extenuante que realizan los perfiles neurodivergentes (especialmente mujeres y perfiles de TDAH/TEA Grado 1) para imitar conductas neurotípicas y encajar. Los enfoques tradicionales premian que el individuo 'se comporte de forma normal', sin medir el coste psicofisiológico. Este camuflaje prolongado es el causante directo de la 'fatiga neurodivergente' (burnout), crisis de identidad, trastornos de despersonalización y severas crisis depresivas en la edad madura.

B. La Doble Excepcionalidad (2E)

La coexistencia simultánea de Altas Capacidades (AACC) junto a un trastorno del neurodesarrollo como el TDAH, la dislexia o el TEA. El sistema educativo y los gabinetes comunes operan bajo una lógica excluyente: si el alumno obtiene calificaciones excelentes se descarta el TDAH, y si muestra problemas de atención se asume que su capacidad intelectual es la media. Las altas capacidades compensan los déficits y viceversa, generando perfiles invisibles que sufren un colapso silencioso por falta de metodologías duales.

C. El Vacío de la Geriatría Neurodivergente

El estudio, diagnóstico y soporte de la población mayor de 60 años con condiciones neurodivergentes. Históricamente considerados trastornos exclusivamente infantiles, hoy nos enfrentamos a la primera generación que envejece con un diagnóstico activo o padeciendo los síntomas sin identificar. No existen residencias adaptadas, gerontólogos formados ni protocolos clínicos para diferenciar el deterioro cognitivo natural por la edad de las crisis de saturación sensorial de un anciano neurodivergente.

D. Ajustes Razonables Organizativos frente a Físicos en Empresas

La reforma profunda de los flujos de gestión empresarial, los canales de comunicación y las metodologías de evaluación del desempeño, frente a las adaptaciones puramente arquitectónicas o materiales (como el suministro de auriculares anti-ruido o paneles aislantes). Un entorno físico óptimo es inútil si el trabajador se enfrenta a instrucciones ambiguas, reuniones improvisadas que rompen la hiperconcentración o evaluaciones basadas en la extroversión y dinámicas sociales informales.

E. Sesgo de Género en el Diagnóstico Tardío de Mujeres

La infradetección sistemática provocada por herramientas diagnósticas tradicionales basadas en patrones masculinos e hiperactivos de los años 80. En las mujeres, el TDAH suele manifestarse como rumiación mental interna y ansiedad, mientras que el autismo se camufla mediante una imitación social altamente sofisticada. Millones de mujeres adultas pasan décadas recibiendo diagnósticos erróneos (como Trastorno Límite de la Personalidad, bipolaridad o depresión refractaria) antes de identificar la raíz real de su sistema nervioso neurodivergente.

3. Matriz Comparativa de Enfoques

Área del Ángulo Muerto	Enfoque Asistencial Clásico	Propuesta de Vanguardia FAND
Masking Social	Premiar la imitación conductual externa y la supresión de rasgos divergentes.	Metodologías clínicas de des-enmascaramiento seguro y prevención activa del burnout.
Doble Excepcionalidad	Atención fragmentada: o se interviene la superdotación o el déficit.	Intervención integral unificada respetando el potencial y el soporte neuropsicológico.
Población Mayor de 60	Inexistente. Se asume que el TDAH/TEA desaparecen en la edad adulta.	Desarrollo de gerontología especializada y adaptación de recursos residenciales.
Entorno Laboral	Soluciones físicas o de mobiliario (auriculares, mamparas aislantes).	Ajustes organizativos en flujos de trabajo, comunicación clara y Job Coaching.
Perfil Femenino	Diagnósticos erróneos crónicos de salud mental generalista (TLP, ansiedad).	Cribados específicos adaptados al fenotipo internalizador y camuflaje sofisticado.

4. Conclusiones y Estrategia ante la Unión Europea (ICE)

El éxito de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) impulsada por FAND radica en esquivar de forma matemática los vetos por 'falta de competencias' de la Comisión Europea. Solicitar normativas comunes sobre educación escolar o sanidad pública hospitalaria derivará en la inadmisión fulminante del expediente en Bruselas, ya que estas competencias corresponden

exclusivamente a los Estados miembros (Artículos 165 y 168 del TFUE).

Por consiguiente, la estrategia legal de FAND debe anclarse exclusivamente en el ámbito del Empleo, la Política Social y el Mercado Interior, invocando formalmente el Artículo 19 del TFUE (No Discriminación) y el Artículo 153.1.b y h del TFUE (Condiciones de Trabajo e Integración Laboral). Al centrar el millón de firmas en la exigencia de una Directiva Marco de Neuroinclusión en las Empresas —regulando la obligatoriedad paneuropea de los ajustes razonables organizativos y la protección contra el despido discriminatorio—, la propuesta superará de forma robusta los filtros de admisibilidad técnicos de Bruselas.